

Document 4 : Reconstruction mammaire après mastectomie totale

Dispositifs et accès aux soins

- La reconstruction mammaire (RM) s'inscrit dans la stratégie de limitation des séquelles et d'amélioration de la qualité de vie des patientes.
- Des outils publics d'aide (plateforme de décision partagée, carte des établissements réalisant la RM, brochures d'information) sont mis à disposition sur le site *cancer.fr*.

Évolution des pratiques et données statistiques

- **Taux globaux** : Le taux de recours à la reconstruction dans les 3 ans suivant une mastectomie totale a progressé en France pour atteindre **34,3 %** (données 2021).
- **Reconstruction Mammaire Immédiate (RMI)** : Elle connaît une forte augmentation, doublant son recours pour atteindre **32,4 %** des interventions en 2024.
- **Facteurs d'inégalités de recours** :
 - *L'âge* : Près de 60 % des femmes de 30-39 ans y ont recours, contre seulement 10 % des femmes de 70-79 ans. La RMI chez les jeunes femmes de 30-39 ans a bondi de 21,6 % à 57,1 % en 10 ans.
 - *Le type d'établissement* : Le taux de reconstruction est plus faible lorsque la mastectomie est réalisée au sein d'un Centre Hospitalier (CH) ou d'un Centre Hospitalo-Universitaire (CHU) par rapport aux autres structures.
 - *Le niveau socio-économique* : Le recours à la reconstruction diminue à mesure que l'indice de défavorisation sociale de la commune de résidence augmente.
 - *La géographie* : De fortes disparités régionales persistent en France concernant l'accès et le choix de reconstruction.

Évolution des techniques chirurgicales utilisés

- **En cas de reconstruction immédiate (RMI)** : La pose de prothèse est devenue la technique majoritaire dans toutes les classes d'âge (par exemple, elle concerne 67 % des RMI chez les 50-59 ans en 2024 contre 49 % en 2014). L'usage des lambeaux (tissus corporels déplacés) a globalement diminué.
- **En cas de reconstruction différée (RMD)** : Pour les interventions réalisées à distance de la mastectomie, les chirurgiens privilégient de plus en plus l'**autogreffe de tissu adipeux** (lipofilling) comme premier acte opératoire, bien que la technique du lambeau reste fréquemment employée. Les options chirurgicales incluent également la réfection de la plaque

aérolo-mamelonnaire (greffe ou dermo-pigmentation) et la symétrisations du sein controlatéral.

Document 5 : Parcours de mauvais pronostic – Expérimentations

- **Objectif** : Amélioration des parcours de soins pour réduire drastiquement les délais diagnostiques et thérapeutiques face aux cancers de mauvais pronostic.
- **Fiches-actions développées** : Structuration du retour d'expérience en fiches concrètes pour renforcer le lien entre la médecine de ville (soins de premier recours) et l'hôpital afin de favoriser une détection et un adressage accélérés lors d'une suspicion de cancer. Les fiches visent également à clarifier les circuits d'accès aux examens au sein des centres d'expertise hospitaliers.